

Douleur pelvienne d'origine musculo-squelettique

WARWIKI

Information pour le patient · Douleur pelvienne provenant des muscles, articulations et nerfs

Certaines douleurs pelviennes ne proviennent pas de la vessie ou des organes reproducteurs, mais des **muscles, articulations, nerfs et tissu conjonctif** du bassin — souvent un plancher pelvien trop tonique, en spasme, qui ne parvient pas à se relâcher. C'est une réalité fréquente et traitable, même lorsque les examens et analyses reviennent normaux.

À propos de cette affection

Les muscles du plancher pelvien peuvent devenir contractés ou entrer en spasme, comme n'importe quel muscle noué. Signes habituels :

- Douleur sourde, pression ou brûlure dans le bassin, le périnée, le bas du dos ou les hanches
- Douleur en **position assise**, lors des rapports sexuels (dyspareunie), à l'usage d'un tampon, ou pendant les selles
- **Besoin urgent ou fréquent d'uriner** causé par les muscles contractés, et non par la vessie elle-même

Causes

Plusieurs facteurs se combinent souvent : tension ou spasme musculaire, antécédent de traumatisme, chirurgie ou accouchement, mauvaise posture, stress (qui provoque une contraction involontaire) et parfois irritation d'un nerf pelvien. Il s'agit fréquemment d'un plancher pelvien « court et tendu » plutôt que faible — c'est pourquoi les exercices de Kegel forcés peuvent aggraver la situation.

COMPRENDRE LES TERMES

Plancher pelvien

L'ensemble des muscles soutenant les organes pelviens.

Plancher hyperactif / tendu

Muscles restant contractés et incapables de se détendre complètement.

Dyspareunie

Douleur lors des rapports sexuels.

Point gâchette

Nœud musculaire sensible pouvant irradier la douleur ailleurs.

Kinésithérapie du plancher pelvien

Physiothérapie qui relâche et rééduque ces muscles.

Décontraction (down-training)

Apprendre à relâcher (et non renforcer) un plancher pelvien trop contracté.

Nerf pudendal

Nerf pelvien dont l'irritation peut provoquer des douleurs.

POURQUOI MES EXAMENS SONT NORMAUX MAIS J'AI TOUJOURS MAL ? Parce que cette douleur provient des muscles et des nerfs, et non d'une infection ou d'une lésion visible à l'imagerie. Un examen normal est une bonne nouvelle — il oriente vers un problème musculaire traitable plutôt que vers quelque chose de grave. Une douleur sans « image » est tout aussi réelle.

Comment on le diagnostique

- Un interrogatoire sur la localisation, le moment et les facteurs aggravants de la douleur
- Un examen qui **évalue les muscles du plancher pelvien** à la recherche de sensibilité et de tension
- L'élimination d'autres causes (infection, etc.) par des examens simples

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **La kinésithérapie du plancher pelvien** est le traitement de référence — relâchement manuel, étirements et décontraction.
- 2 **Soins personnels** — chaleur, mouvements doux, relaxation/respiration, posture, et réduction de la constipation et des irritants vésicaux.
- 3 **Médicaments ou injections** — médicaments contre la douleur neuropathique ou injections dans les points gâchette.
- 4 **Prise en charge du stress et du sommeil**, qui influencent fortement la tension musculaire.

Vivre avec

- Repérez et relâchez les **contractions involontaires** (mâchoire, fessiers, plancher pelvien) tout au long de la journée.
- Utilisez la chaleur et des étirements doux ; évitez les positions assises prolongées sur une surface dure.
- La progression est généralement progressive sur plusieurs semaines de traitement — la régularité est essentielle.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Une douleur pelvienne **sévère** nouvelle ou de la fièvre
- De nouveaux troubles intestinaux ou urinaires, ou un engourdissement/une faiblesse dans les jambes
- Une douleur après une chute ou un traumatisme, ou du sang dans les urines ou les selles

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La douleur pelvienne provient souvent de muscles pelviens trop contractés et hyperactifs — réelle et traitable même si les examens sont normaux.
2. La kinésithérapie du plancher pelvien (pour le détendre, pas le renforcer) est le traitement principal, complété par les soins personnels, les médicaments et la gestion du stress.
3. L'amélioration est progressive. Consultez en cas de douleur sévère nouvelle, de fièvre, d'engourdissement ou faiblesse dans les jambes, ou de troubles intestinaux/urinaires.